ATLAS

CLÍNICO-GEOMÉTRICO DEL ESPECTRO AFECTIVO

Nosología · fenomenología · curso · incertidumbre



Fernando José Segovia Vera

Modelo del atlas · edición revisada v3 · 28 octubre 2026

Edición revisada · evidencia atribuida · geometría conceptual sin calibración individual.

F criterio formal · E hallazgo empírico · I interpretación · H hipótesis · G geometría editorial

Cómo leer este atlas

01 · Diagnóstico

Las categorías DSM-5-TR e ICD-11 delimitan episodios y trastornos. El criterio diagnóstico se lee en texto; ninguna distancia gráfica lo sustituye.

02 · Dimensiones

Ánimo depresivo, activación, sueño, función y psicopatología concomitante pueden variar de forma parcialmente independiente.

03 · Curso

Las curvas son viñetas geométricas; altura, pendiente, área y grosor no son frecuencias poblacionales, pronósticos ni dosis.

RECORRIDO EDITORIAL

04–07	Matriz fenomenológica · 24 perfiles × 21 variables
08–09	Cartografía de regiones y solapamientos
10–18	Nueve láminas longitudinales + curso inducido en p. 24
19–20	Transiciones, moduladores y fármacos
21	Auditoría crítica de originales
22–30	Ampliación clínica, método y bibliografía verificable

Clave epistemológica: F = criterio formal; E = hallazgo empírico; I = interpretación clínica; H = hipótesis o propuesta; G = geometría editorial no calibrada.

F · resumen de criterios; alcance de cotejo en p. 26 | fuentes N1–N4

Gramática diagnóstica y límites

Depresión mayor

DSM-5-TR / ICD-11

Episodio depresivo mayor; el trastorno se clasifica como único o recurrente si no hay historia de manía o hipomanía.

Depresión persistente

DSM-5-TR

Ánimo deprimido crónico. DSM-5-TR retiró especificadores inaplicables; la persistencia no limita la intensidad. Véanse N2 y la nota operativa de p. 22.

Bipolar II

DSM-5-TR

Al menos un episodio hipomaníaco y uno depresivo mayor; nunca un episodio maníaco.

Bipolar I

DSM-5-TR

Al menos un episodio maníaco. El episodio depresivo mayor es frecuente, pero no requisito diagnóstico.

Ciclotimia

DSM-5-TR / ICD-11

DSM: síntomas subumbrales. ICD-11 permite periodos hipomaníacos umbral; sus reglas no son intercambiables. Véase p. 22.

Mixticidad

DSM / ICD / propuesta

“Con características mixtas” es especificador DSM; ICD-11 reconoce episodio mixto en bipolar I. La mezcla clínica amplia de Koukopoulos es propuesta.

Ciclación rápida

DSM-5-TR / ICD-11

Modificador de curso en bipolar I o II: cuatro o más episodios del estado de ánimo en 12 meses; cambios horarios no equivalen a episodios.

Psicosis

DSM-5-TR / ICD-11

La psicosis durante la elevación sindrómica sitúa el episodio en el campo de la manía, no de la hipomanía. La psicosis depresiva exige caracterización propia.

La atribución diagnóstica requiere entrevista, duración, deterioro, exclusiones y contexto. La figura no resuelve el diagnóstico diferencial con sustancias, enfermedad médica o trastornos psicóticos.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda A

Experiencia afectiva y activación

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Ánimo depresivo	Anhedonia	Ansiedad	Irritabilidad	Mezcla simultánea	Activación subjetiva	Pensamiento acelerado
01	Depresión única, remisión completa	D	R	R	V	V	·	·	·
02	Depresión única, residuo	D	R	R	V	V	·	·	·
03	Depresión recurrente, remisión	D	R	R	V	V	·	·	·
04	Depresión recurrente, residuo	D	R	R	V	V	·	·	·
05	Depresión persistente, curso puro	D	R	V	V	V	·	·	·
06	Persistente + episodio mayor	D	R	R	V	V	·	·	·
07	Depresión breve recurrente	O	R	·	V	V	·	·	·
08	Depresión: patrón estacional	S	R	·	V	V	·	·	·
09	Depresión + anxious distress	S	R	·	R	V	·	·	·
10	Depresión melancólica	S	R	R	V	V	·	·	·
11	Depresión: características atípicas	S	R	·	V	V	·	·	·
12	Depresión con psicosis	S	R	R	V	V	·	·	·
13	Depresión + características mixtas DSM	S	R	·	V	V	R	V	V
14	Depresión + elevación breve	O	R	R	V	V	·	R	·
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	R	·	V	V	·	R	·
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	R	R	V	V	·	·	V
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	R	·	V	V	·	R	V
18	Bipolar II, depresión mixta	S	R	R	V	V	R	R	V
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	·	·	V	·	R	V
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	R	R	V	V	·	·	V
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	·	·	V	·	R	V
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	R	·	V	V	R	R	V
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	·	·	·	·	·	·
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	·	·	·	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I.

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda B

Expresión episódica

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Hipomanía (episodio)	Manía	Psicosis en episodio	Enlentecimiento	Agitación	Menor necesidad sueño	Alteración sueño
01	Depresión única, remisión completa	D	·	·	·	·	·	·	V
02	Depresión única, residuo	D	·	·	·	·	·	·	V
03	Depresión recurrente, remisión	D	·	·	·	·	·	·	V
04	Depresión recurrente, residuo	D	·	·	·	·	·	·	V
05	Depresión persistente, curso puro	D	·	·	·	·	·	·	V
06	Persistente + episodio mayor	D	·	·	·	·	·	·	V
07	Depresión breve recurrente	O	·	·	·	·	·	·	V
08	Depresión: patrón estacional	S	·	·	·	·	·	·	V
09	Depresión + anxious distress	S	·	·	·	·	·	·	V
10	Depresión melancólica	S	·	·	·	R	·	·	R
11	Depresión: características atípicas	S	·	·	·	·	·	·	V
12	Depresión con psicosis	S	·	·	R	·	·	·	V
13	Depresión + características mixtas DSM	S	·	·	·	·	V	V	V
14	Depresión + elevación breve	O	·	·	·	·	·	·	V
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	·	·	·	·	·	·	V
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	R	·	·	·	·	V	V
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	R	·	·	·	·	V	V
18	Bipolar II, depresión mixta	S	R	·	·	·	V	V	V
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	R	·	·	·	V	V
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	·	R	·	·	·	V	V
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	R	·	·	·	V	V
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	·	R	·	·	V	V	V
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	·	·	·	·	·	V
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	R	·	·	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I.

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

I · síntesis editorial | D/S/O = tipo de entidad | matriz referida a DSM salvo nota: N1–N4, N6

Matriz fenomenológica · banda C

Curso e impacto

Marco temporal: episodio índice e historia de curso; las remisiones describen el seguimiento, no síntomas actuales.

			Persistencia	Recurrencia	Carga residual	≥4 episodios/año	Impacto funcional	Reactividad del ánimo	Estacionalidad
01	Depresión única, remisión completa	D	·	·	·	·	R	·	·
02	Depresión única, residuo	D	·	·	R	·	R	·	·
03	Depresión recurrente, remisión	D	·	R	V	·	R	·	·
04	Depresión recurrente, residuo	D	·	R	R	·	R	·	·
05	Depresión persistente, curso puro	D	R	·	R	·	R	·	·
06	Persistente + episodio mayor	D	R	·	R	·	R	·	·
07	Depresión breve recurrente	O	·	R	V	·	R	·	·
08	Depresión: patrón estacional	S	·	R	V	·	R	·	R
09	Depresión + anxious distress	S	·	·	·	·	R	·	·
10	Depresión melancólica	S	·	·	·	·	R	V	·
11	Depresión: características atípicas	S	·	·	·	·	R	R	·
12	Depresión con psicosis	S	·	·	·	·	R	·	·
13	Depresión + características mixtas DSM	S	·	·	·	·	R	·	·
14	Depresión + elevación breve	O	·	·	·	·	R	·	·
15	Ciclotimia DSM: subumbral	D	R	R	V	·	R	·	·
16	Bipolar II, predominio depresivo	D	·	R	R	·	R	·	·
17	Bipolar II, hipomanía visible	D	·	R	V	·	R	·	·
18	Bipolar II, depresión mixta	S	·	·	·	·	R	·	·
19	Bipolar I, manía inicial	D	·	·	·	·	R	·	·
20	Bipolar I, predominio depresivo	D	·	R	V	·	R	·	·
21	Bipolar I, manía recurrente	D	·	R	V	·	R	·	·
22	Bipolar I, mixto: ver sistemas	S	·	·	·	·	R	·	·
23	Bipolar I/II, ciclación rápida	S	·	R	V	R	R	·	·
24	Episodio afectivo con psicosis	S	·	·	·	·	R	·	·

R = rasgo seleccionado del perfil V = variable / posible · = sin inferencia; nunca significa ausencia

Tipo de entidad: D = diagnóstico base · S = especificador/presentación · O = otro especificado. Todas las celdas: I. Reactividad del ánimo: R = conservada (fila 11); V en la fila 10 = puede estar ausente (p. 22).

R no equivale a criterio obligatorio: depresión mayor exige ánimo deprimido o anhedonia. Residuo es descripción clínica; no sinónimo automático de remisión parcial. Evaluar riesgo suicida en todos los perfiles.

Conectores entre perfiles y capas

Familias diagnósticas

Depresiva	Otra especificada	Ciclotímica	Bipolar II	Bipolar I
01–06 + capas 08–13	07 · 14	15	16–18	19–22

Capas que atraviesan familias

Características mixtas	13 · 18 · 22	capa formal; propuesta amplia en p. 23
Psicosis	12 · 24	anotar episodio y relación temporal
Ciclación rápida	23	frecuencia de episodios umbral
Otros especificadores	08–11	estación, ansiedad, melancolía, atipicidad

Los conectores indican comparación y solapamiento fenomenológico, no conversión inevitable entre diagnósticos.

Una depresión con síntomas mixtos no equivale por sí sola a bipolaridad. El primer episodio maníaco puede reclasificar longitudinalmente un antecedente depresivo; el diagrama no asigna probabilidades.

G · geometría conceptual | sin datos de distribución | fundamentos dimensionales: P04, P05

Cartografía de dimensiones, no de gravedad

G · El plano representa combinaciones de síntomas; los diagnósticos no reciben posiciones ni distancias.

I · P04 respalda separar activación y valencia depresiva; P05 describe activación/inhibición como un eje más un componente emocional, por lo que no sostiene por sí solo que ambos ejes sean independientes.

↑ ACTIVACIÓN

Activación sin depresión prominente

Coexistencia alta–alta

Mixticidad como capa de síntomas concurrentes; su atribución formal depende del sistema y del episodio.

Pocos síntomas en ambos ejes

No informa por sí solo sobre función o residuo.

Depresión con activación baja

SÍNTOMAS DEPRESIVOS →

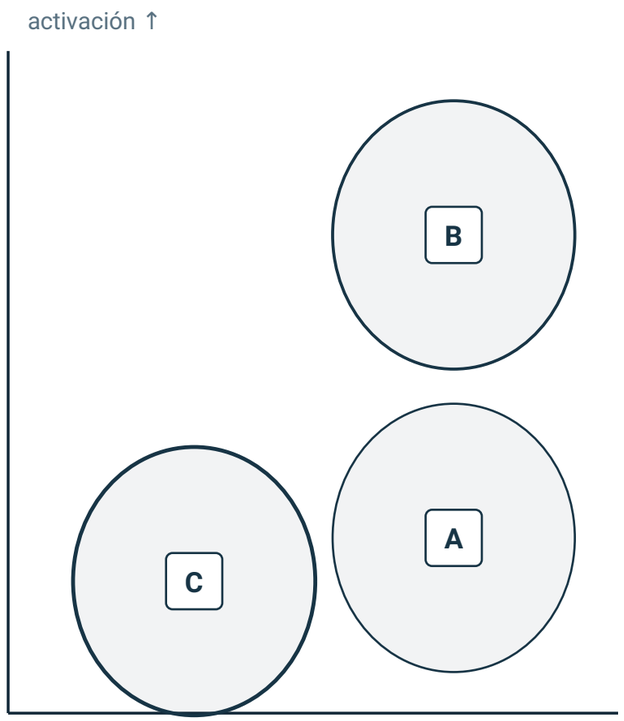
Fuera del plano

Persistencia, bipolaridad y psicosis requieren historia y criterios propios.
E/I · Judd registra los mismos niveles semanales de gravedad (sindrómico, menor, subsindrómico) en depresión unipolar (P02), bipolar I (P12) y bipolar II (P13): sostiene el solapamiento de rangos, no su equivalencia clínica.

La identidad se conserva al cambiar de plano

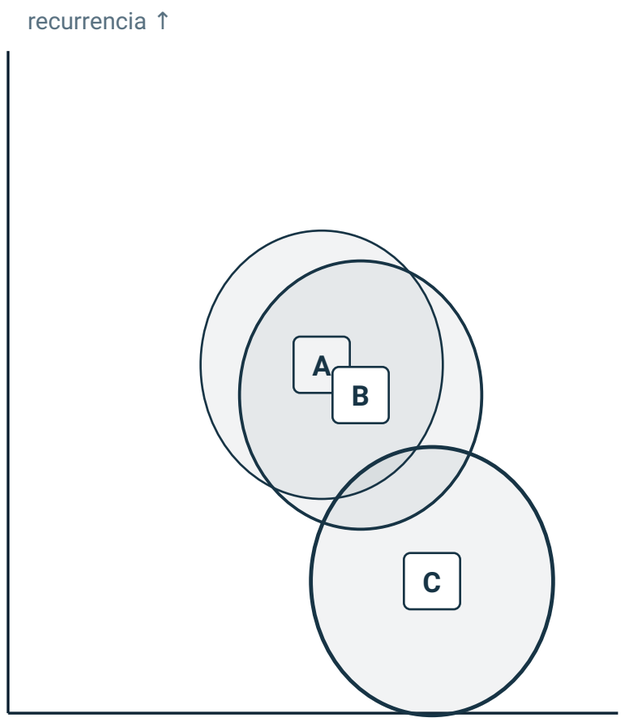
G · A = episodio inhibido · B = episodio activado · C = síntomas residuales. Ejemplos hipotéticos, no clases empíricas.

Síntomas



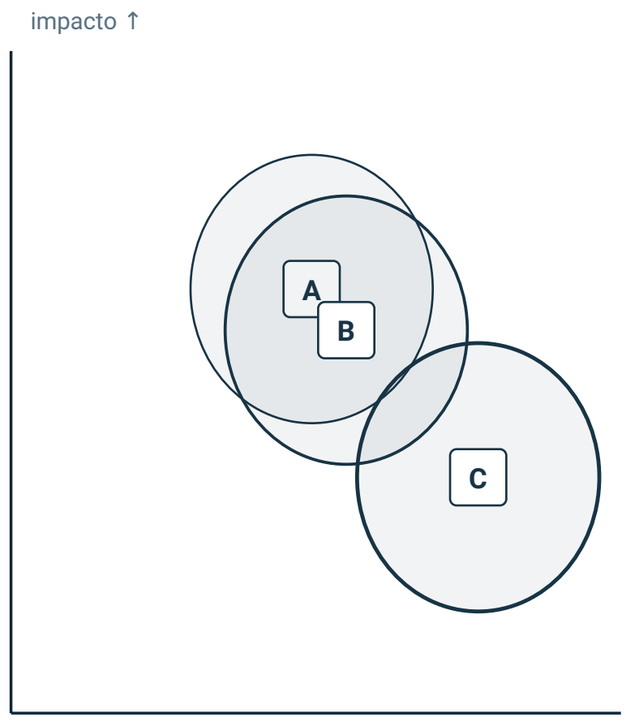
A y B comparten depresión; difieren en activación.

Curso



A y B se solapan; C ilustra residuo persistente.

Consecuencias



A y B comparten impacto; C conserva carga residual.

I · Qué permite la comparación

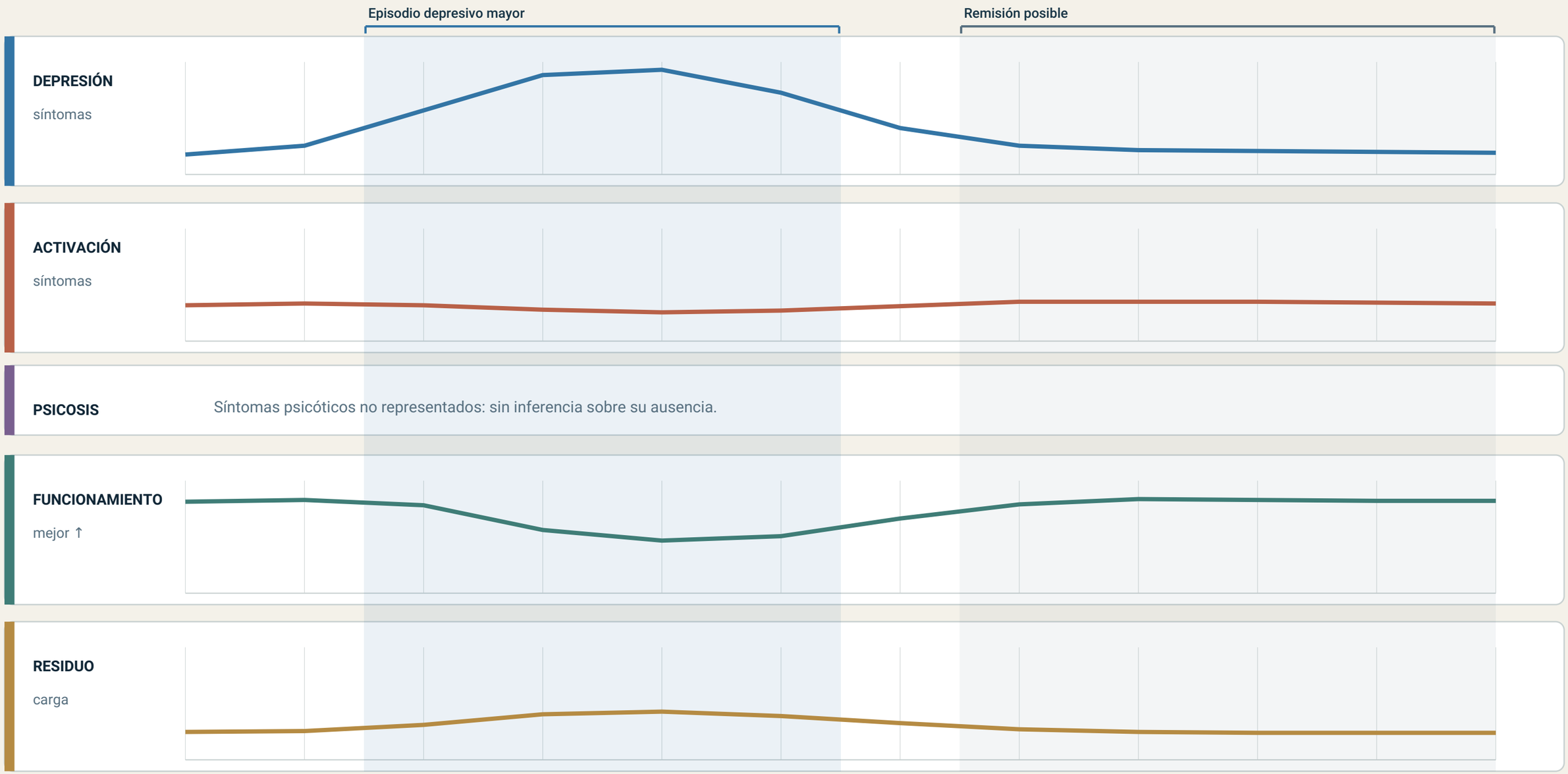
Un mismo perfil puede parecer próximo a otro en un plano y distinto en otro. La geometría no establece taxones, probabilidades, gravedad relativa o validez diagnóstica.

Los contornos conservan letra y estilo. Opacidad y tamaño facilitan lectura; no representan densidad ni dispersión medidas.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 01 · Episodio depresivo único

Un episodio puede remitir por completo o dejar síntomas residuales; no se infiere recurrencia.

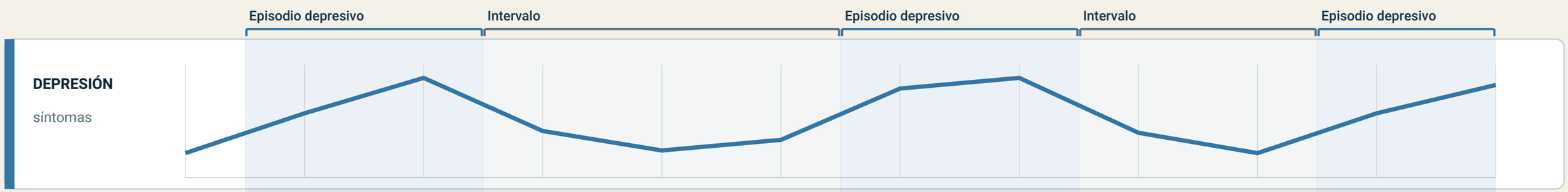


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

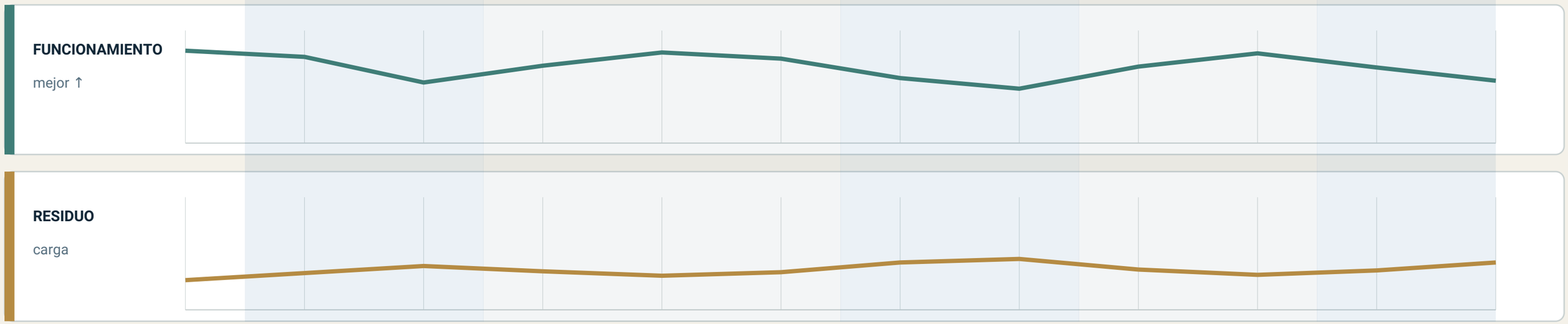
G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 02 · Depresión recurrente

Recurrencia DSM: al menos dos meses consecutivos entre episodios sin cumplir criterios de episodio mayor (N4).



PSICOSIS Síntomas psicóticos no representados: sin inferencia sobre su ausencia.



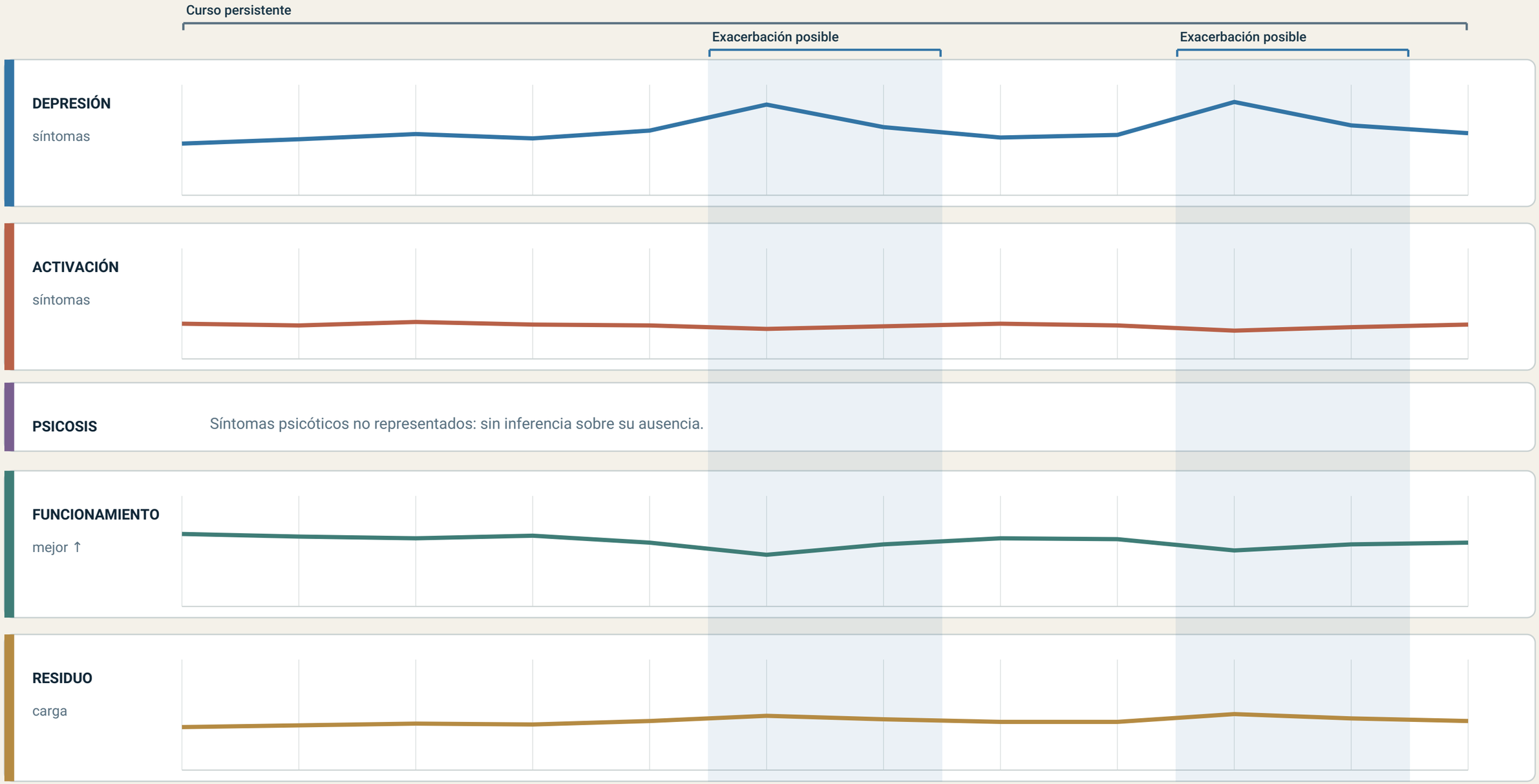
TIEMPO RELATIVO →

G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 03 · Depresión persistente

La persistencia del ánimo depresivo puede coexistir con episodios mayores superpuestos.

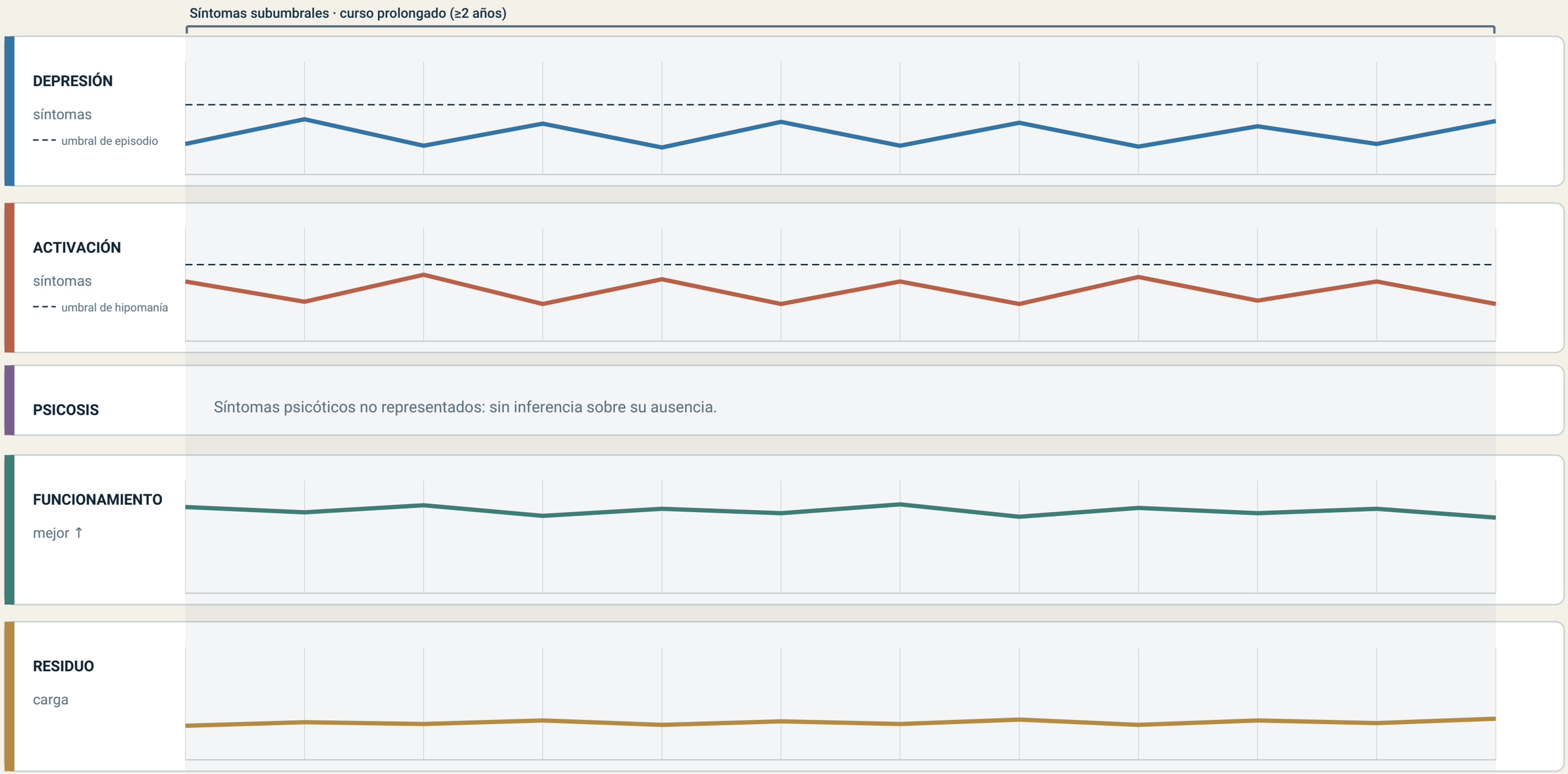


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 04 · Ciclotimia DSM

DSM: ≥2 años en adultos, síntomas ≥mitad del tiempo y sin intervalos libres >2 meses; malestar o deterioro (N6).

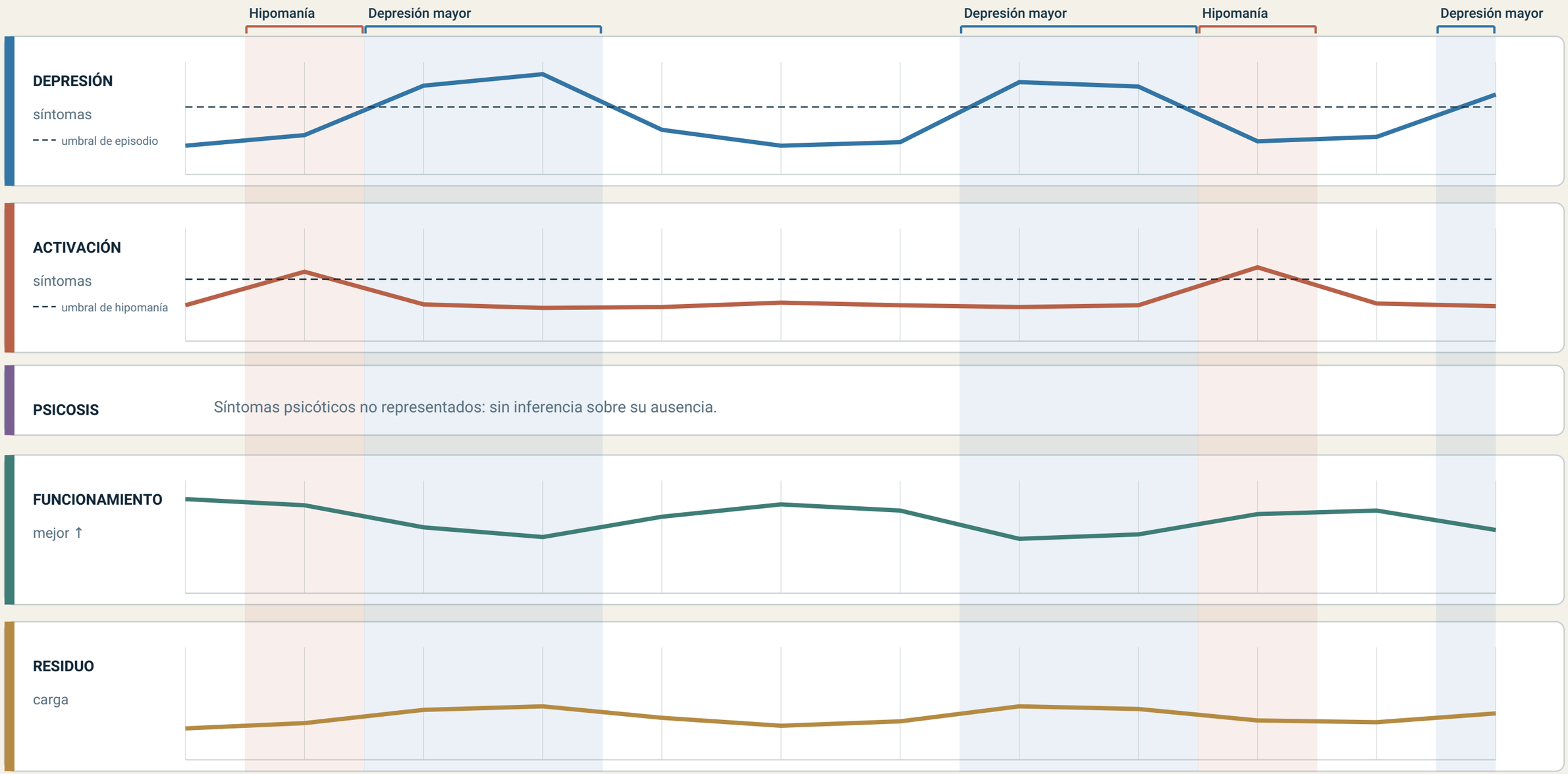


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 05 · Bipolar II

Al menos una hipomanía y una depresión mayor; la hipomanía no incluye psicosis.

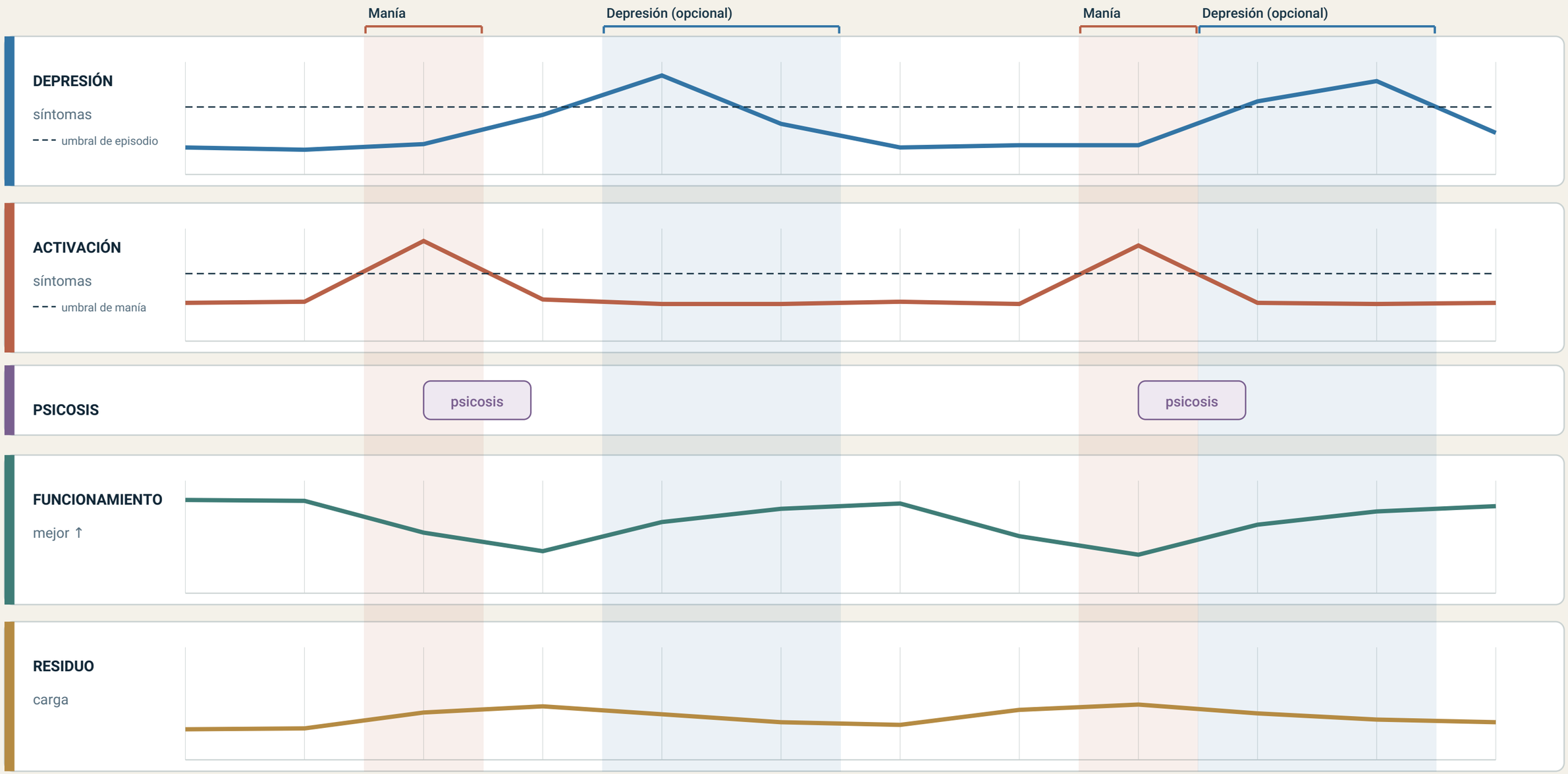


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 06 · Bipolar I

Una manía basta para el diagnóstico; pueden darse episodios depresivos, pero no se exigen.

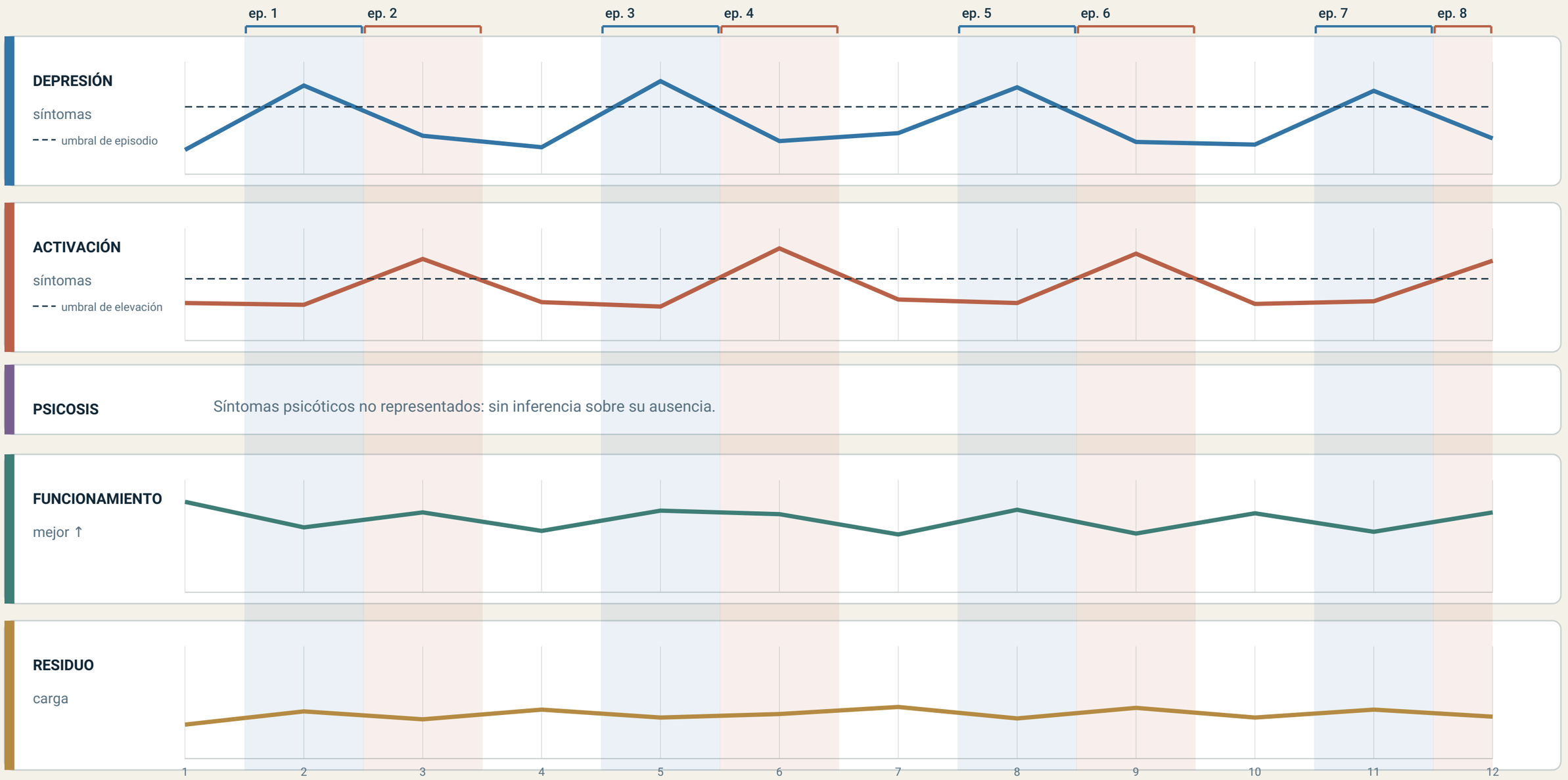


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 07 · Ciclación rápida

DSM: ≥4 episodios umbral en 12 meses; separar por remisión o cambio de polaridad. Viñeta de ejemplo, no patrón típico.



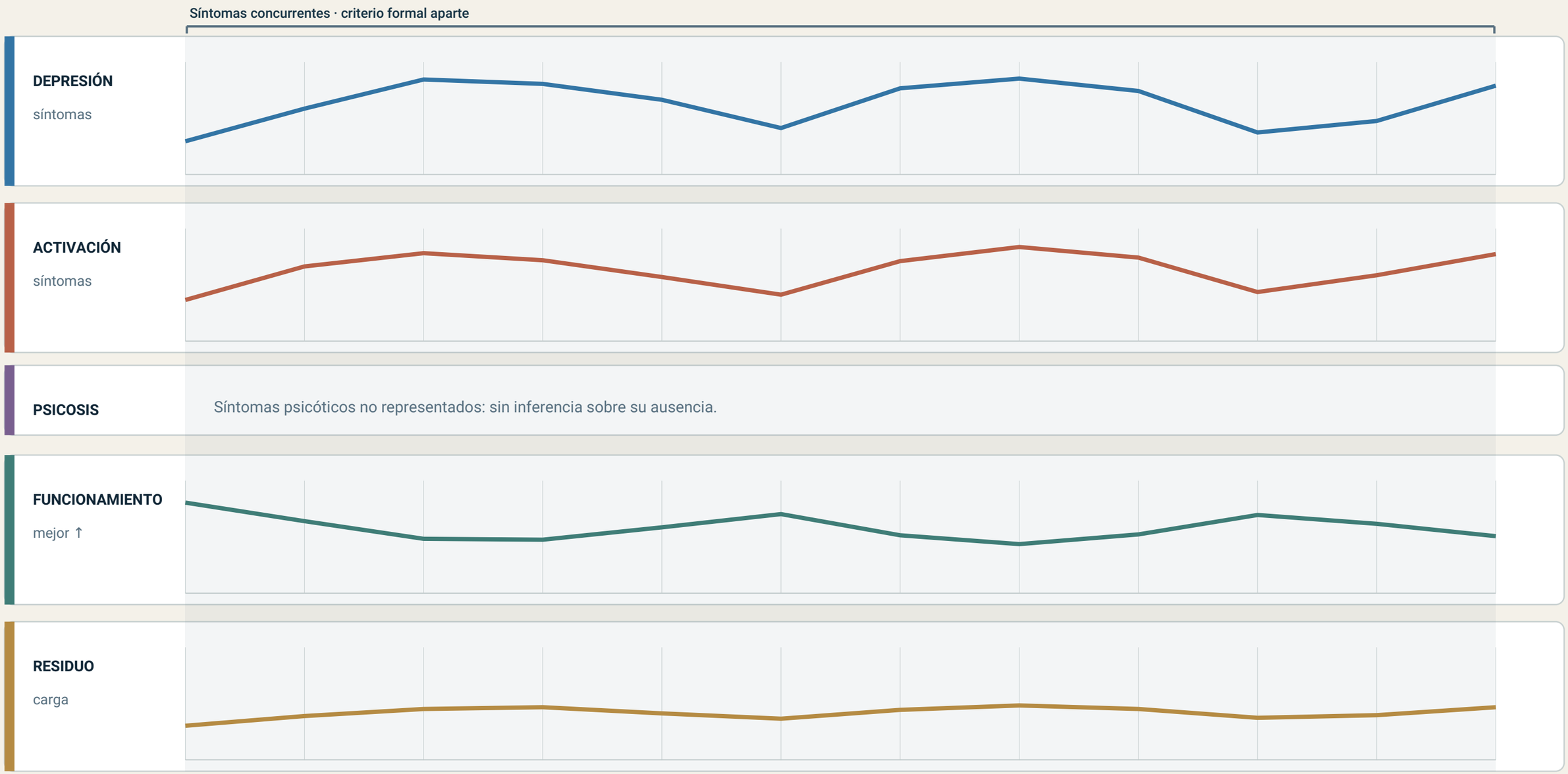
NOTAS ≥4 episodios / 12 meses No son cambios horarios MESES 01–12 →

G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración. Línea discontinua: umbral esquemático de episodio, sin calibración; solo se dibuja donde distingue el diagnóstico (láminas 04–07).

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 08 · Mixticidad predominante

Constructo fenomenológico: activación y síntomas depresivos coocurren. Aplicar el especificador formal solo si se cumplen sus criterios.

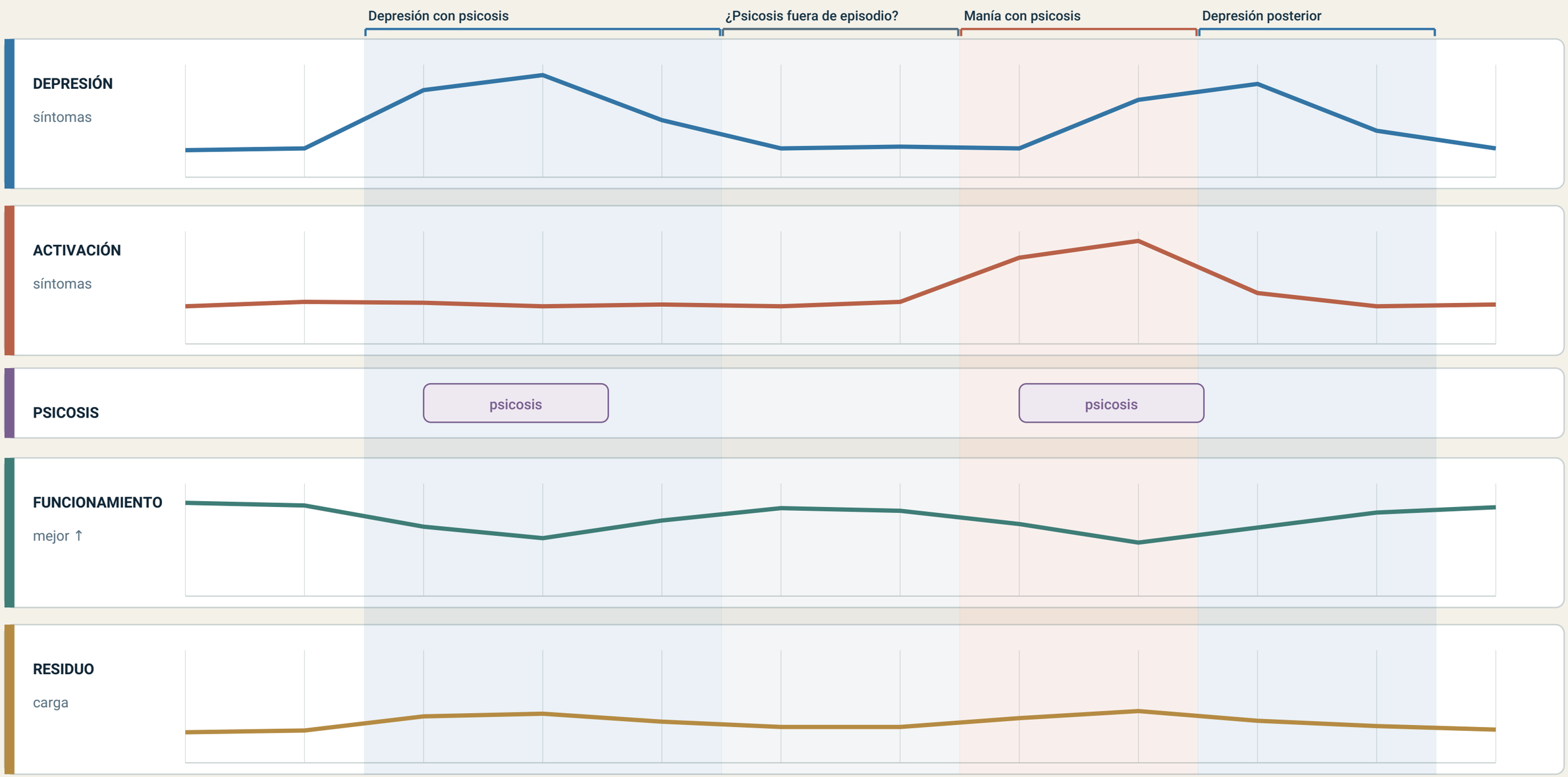


G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

G · viñeta ilustrativa + F · marco clínico N1–N4, N6 | E · contexto longitudinal P01, P02, P12–13

Curso 09 · Dimensión psicótica episódica

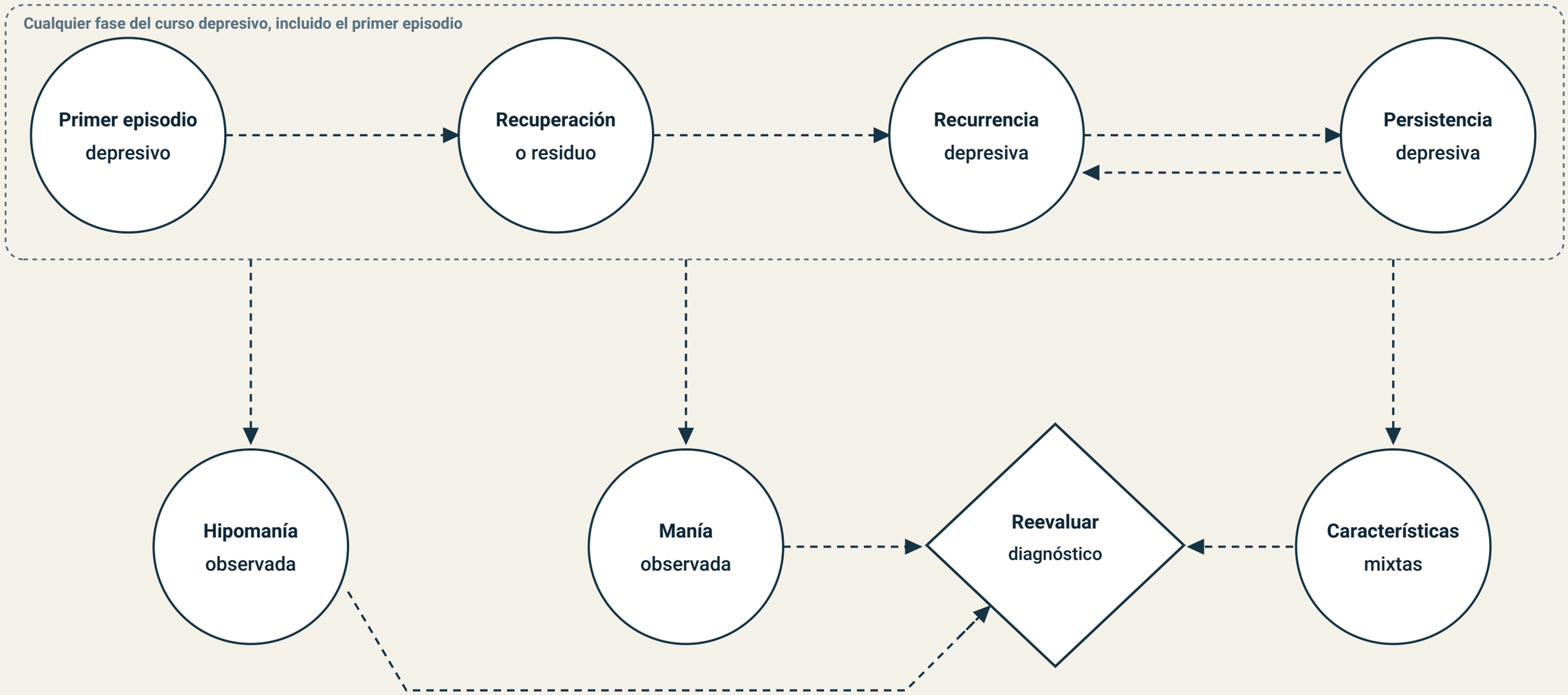
Los síntomas psicóticos se anotan respecto del episodio y su temporalidad; no son un polo adicional.



G · altura cualitativa sin unidades: no comparar amplitudes entre paneles. Riesgo suicida: evaluación independiente en toda fase. La lámina de ciclación usa 12 meses; las demás, tiempo relativo.
G · Franjas y llaves: fases ilustrativas, sin calibración.

I/G · relaciones clínicas posibles | evidencia de seguimiento P14; sin tasas trasladadas al gráfico

Transiciones y revisión diagnóstica



I · Los caminos son clínicos; las probabilidades no se han estimado

Círculo = estado o fenómeno observado. Rombo = acto de evaluación. El recuadro discontinuo agrupa cualquier fase del curso depresivo, incluido el primer episodio: desde él puede observarse hipomanía, manía o características mixtas, sin recurrencias intermedias. Los síntomas mixtos aislados no bastan para reclasificar como bipolar. La persistencia puede incluir episodios mayores superpuestos.

E · Fiedorowicz et al. (P14): asociación prospectiva con síntomas hipomaníacos iniciales; muchas conversiones no los presentaban. No se traslada una tasa de cohorte al individuo.
E · Angst et al. (P18): en una cohorte hospitalaria, cada nuevo episodio depresivo conlleva un riesgo de manía a lo largo de la vida; aquí se dibuja como camino posible, no como probabilidad.

Moduladores y tratamiento: capa separada

Sueño y ritmos

Desfase circadiano, privación de sueño, recuperación

Sustancias y enfermedad

Intoxicación, abstinencia, causas médicas

Tratamientos

Exposición, respuesta, efectos adversos, posible activación

Contexto

Estrés, apoyo, trauma, acontecimientos, funcionamiento

Fármacos: preguntas clínicas, no vectores causales fijos

Antidepresivos	Indicación y polaridad; vigilar activación y atribución temporal.
Estabilizadores / antipsicóticos	Evidencia dependiente de fase, molécula, formulación y desenlace.
Litio, lamotrigina, etc.	No reducir efecto clínico a afinidad receptorial o a “dirección” en el plano.

Ki ≠ ocupación ≠ respuesta clínica. Las guías terapéuticas se consultan por fase y situación individual; este atlas no ofrece una pauta de prescripción.

Auditoría de los originales disponibles

“Historia natural probabilística”	Sin datos calibrados, las flechas pasan a ser relaciones posibles y no probabilidades.
“Bipolar I = manía + depresión”	Se corrige: basta al menos un episodio maníaco; la depresión mayor puede faltar.
Hipomanía y psicosis en la misma elevación	Se distingue manía con psicosis de hipomanía. La psicosis depresiva se codifica por separado.
Mixticidad / ciclación como filas diagnósticas	Se representan como especificador o constructo transversal, según el sistema y el contexto.
Un único eje “depresión ↔ manía”	Se separan síntomas depresivos y activación; ambos pueden coexistir.
Trazos y sombras con aparente medición	Se retiran escalas numéricas implícitas y se declara geometría editorial no calibrada.
“Vectores” farmacológicos universales	Se reemplazan por preguntas sobre fase, evidencia, tiempo y efectos; sin causalidad mecanicista gráfica.

Alcance de la auditoría: un SVG recuperado (con tres paneles raster incrustados) y nueve PNG longitudinales. El SVG “Sistema_integrador_espectro_afectivo_v2.svg” y ocho imágenes mencionadas no estaban accesibles en el hilo al iniciar esta edición.

Precisiones temporales y terminológicas

Depresión persistente · N2

La ficha APA confirma ≥2 años de ánimo deprimido en adultos y explica por qué se elimina “distimia” del nombre. También retira especificadores inaplicables. No se equipara con depresión leve.

Ciclotimia · N3 / N6

DSM-5-TR: síntomas subumbrales, ≥2 años y al menos la mitad del tiempo; sin intervalos libres >2 meses (N6). ICD-11 permite hipomanía umbral y aplica reglas propias (N3, p. 240).

Remisión y residuo

La matriz resume el episodio índice y la historia. Remisión completa describe el estado de seguimiento; “residuo” se usa como descripción clínica, sin asignar automáticamente un código de remisión parcial.

Con características mixtas · P17

En la depresión, el recuento DSM emplea síntomas contrapolares seleccionados; irritabilidad, distractibilidad y agitación no bastan para ese recuento. No se intercambia con el constructo amplio de Koukopoulos.

En la matriz, los síntomas contrapolares del recuento DSM (activación subjetiva, menor necesidad de sueño, pensamiento acelerado) figuran como V; la agitación se muestra solo como rasgo descriptivo (N4).

Nombres y sistemas

Fila 22: DSM = manía con características mixtas; ICD-11 = episodio mixto. “Anxious distress” se conserva en inglés con traducción descriptiva: malestar ansioso; no se certifica una traducción oficial española.

Reactividad del ánimo: R en atípica (fila 11, conservada). En melancólica (fila 10) figura como V porque el criterio A se cumple con anhedonia generalizada o con ausencia de reactividad (N4).

Dos meses no significan lo mismo

Separación depresiva, remisión y continuidad ciclotímica son reglas distintas. CDDR (p. 235) admite episodios breves en ciclación rápida; no equivale sin más al criterio DSM. No inferirlo de un cruce gráfico.

Fuentes y alcance en p. 26. Resumen clínico propio: el CDDR y los criterios DSM se cotejan por separado; la reproducción gubernamental no sustituye la edición española oficial.

El espectro: cuatro propuestas y sus límites

Akiskal · P06

Amplía la clínica bipolar mediante temperamentos y formas de expresión atenuadas.

H: taxonomía de espectro; no implica que cada perfil sea un diagnóstico formal.

Ghaemi · P07

Recupera una lectura amplia de la enfermedad maníaco-depresiva y discute el corte unipolar/bipolar.

H: marco histórico y nosológico; no prueba una única dimensión biológica.

Angst y Gamma · P08

Exploran umbrales de hipomanía más amplios y síntomas subumbrales.

E/H: la prevalencia y composición cambian con la definición; no valida cualquier ampliación.

Koukopoulos · P09–10

Centra la depresión mixta en excitación, agitación y otros signos clínicos.

H: constructo con validación limitada; no equivalente al especificador DSM.

E · Evidencia longitudinal y límite inferencial

Judd: síntomas depresivos y subsindrómicos predominan en las cohortes de bipolar I y II (P12–13); esto informa sobre tiempo sintomático, no sobre altura de picos. Henry (P05): validación dimensional en 141 pacientes dentro de un ensayo abierto con olanzapina; describe activación/inhibición como un eje y un componente emocional aparte, por lo que no sostiene por sí sola la independencia de depresión y activación (P04 sí separa la activación de la valencia emocional). La estructura factorial no calibra este atlas ni establece una continuidad causal única.

I · Las viñetas bipolares se han hecho menos simétricas; no son una reconstrucción de las semanas de Judd ni un patrón universal de enfermedad.

Curso 10 · Exposición, síntomas y reevaluación

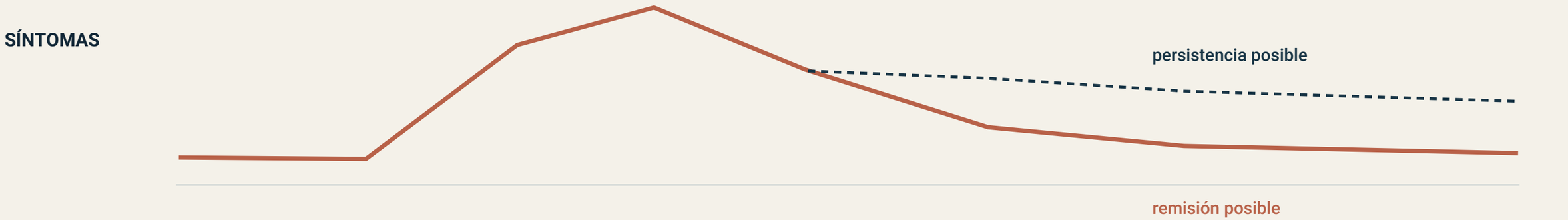
Una asociación temporal orienta la atribución; la secuencia por sí sola no demuestra causalidad.

Antes
historia basal

Exposición
sustancia / medicamento

Retirada
intoxicación / abstinencia

Seguimiento
persistencia o remisión



I · Preguntas de atribución
Qué se consumió, cuándo y por qué vía; cambios de medicación; sueño; síntomas previos; síntomas en abstinencias documentadas; causas médicas; observación de terceros. Estimulantes, catinonas y GHB exigen cronología específica, no una regla común de duración.

F / I · Separar síndrome y causa
Distinguir trastorno inducido, trastorno primario y otra afección médica. Un síndrome hipomaníaco o maníaco completo que persiste más allá del efecto del antidepresivo tiene relevancia diagnóstica; uno o dos signos de activación no bastan (N4).

I · Sin umbral universal de un mes
El plazo aproximado usado en algunas descripciones diagnósticas no es un reloj causal aplicable a cualquier sustancia. Considerar farmacología, intoxicación, abstinencia, exposición repetida y curso previo. Agitación, acatisia, TDAH, labilidad y delirium forman parte del diferencial.

Riesgo suicida y seguridad se evalúan de forma independiente en toda fase. Curvas sin unidades, dosis ni tiempos de eliminación asignados.

Psicosis, catatonía y contexto perinatal

F · Psicosis y trastorno esquizoafectivo

Registrar si la psicosis está limitada a episodios afectivos o si también aparece fuera de ellos. El diagnóstico esquizoafectivo usa relaciones temporales distintas en DSM e ICD; no se obtiene añadiendo “psicosis” a una depresión o una manía. CDDR: sección 6A21, pp. 170–176 (N3); comparación de sistemas P17.

F / I · Catatonía

Explorar signos motores, conductuales y de respuesta al entorno mediante evaluación específica. Puede acompañar trastornos afectivos y otras condiciones; no equivale a enlentecimiento depresivo. CDDR: catatonía, pp. 201–207 (N3).

F / I · Periparto

Registrar relación temporal con embarazo y posparto, historia afectiva, sueño y síntomas psicóticos. La ventana formal depende del sistema; la vigilancia clínica no se limita a una casilla temporal. No se equiparan inicio periparto y cualquier episodio durante la maternidad.

I · La vivencia se recoge sin convertirla en biomarcador

El tiempo vivido, la pérdida de resonancia afectiva, el cuerpo, la intersubjetividad y el sentido del futuro pueden enriquecer la descripción clínica. Esta edición los conserva como preguntas abiertas de entrevista; no añade una escala fenomenológica ni interpreta sus respuestas como evidencia de bipolaridad. Una ampliación teórica de esa capa requeriría un marco y bibliografía propios.

Las capas transversales no son una escala de gravedad. El deterioro funcional puede fluctuar y recuperarse; la psicosis requiere atribución y evaluación propias.

Método de verificación y fuentes normativas

Alcance real de esta revisión

Se verificaron metadatos y resúmenes de 18 artículos en PubMed: título, autoría abreviada, revista, fecha, volumen, páginas y DOI. No es una revisión sistemática ni una evaluación integral de sesgos. Los resúmenes no sustituyen el texto completo; las figuras no se ajustan a sus datos.

N1 · APA	DSM-5-TR: actualización y cambios bipolar I/II. Fichas oficiales, no manual íntegro.	psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/updates-to-dsm/updates-to-dsm-5-tr-criteria-text · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N2 · APA	Persistent Depressive Disorder: retirada de “dysthymia” y especificadores inaplicables.	psychiatry.org/getmedia/fd3dfaad-d409-4e94-8605-0350adec5b91/APA-DSM5TR-PersistentDepressive.pdf · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N3 · OMS	CDDR 2024: cotejo selectivo directo; episodios pp. 212–224, bipolar pp. 225–243, ciclotimia p. 240.	who.int/publications/i/item/9789240077263 · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N4 · Extractos DSM-5	National Academies (2019), Selected Health Conditions: reproducción de criterios; no DSM-5-TR.	ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559511/ · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N5 · NICE	CG185: recomendaciones por fase; página accesible en búsqueda, apertura directa 403 en esta revisión.	nice.org.uk/guidance/cg185/chapter/recommendations · corte 28-oct-2026 · enlace activo
N6 · VAC Canadá	Criterios derivados de DSM-5-TR: manía, hipomanía, depresión, bipolar I/II y ciclotimia; revisión 2025.	veterans.gc.ca/…/entitlement-eligibility-guidelines/az-index/bipolar-and-related-disorders · corte 28-oct-2026 · enlace activo

Cotejo: CDDR íntegro descargado de una copia del documento OMS alojada en drugsandalcohol.ie; se leyeron las secciones pertinentes, no las 852 páginas. N6 reproduce criterios derivados de DSM-5-TR. No se dispuso de todo el manual APA ni de su traducción española oficial; detalles de especificadores no cubiertos siguen sujetos a cotejo editorial.

Copia íntegra CDDR consultada: WHO 2024, ISBN 9789240077263 (enlace al PDF)

F = criterio formal resumido, con alcance de cotejo declarado; E = hallazgo empírico atribuido a su fuente; I = interpretación clínica (síntesis editorial); H = hipótesis o propuesta; G = geometría editorial no calibrada. Fuente por bloque/página.

Bibliografía verificada · 1

P01 Long-term symptomatic status of bipolar I vs. bipolar II disorders.

Lewis L Judd, Pamela J Schettler, Hagop S Akiskal et al. The international journal of neuropsychopharmacology. 2003 Jun;6(2):127-37.

DOI 10.1017/S1461145703003341 | PMID 12890306

P02 A prospective 12-year study of subsyndromal and syndromal depressive symptoms in unipolar major depressive disorders.

L L Judd, H S Akiskal, J D Maser et al. Archives of general psychiatry. 1998 Aug;55(8):694-700.

DOI 10.1001/archpsyc.55.8.694 | PMID 9707379

P03 The functional impact of subsyndromal depressive symptoms in bipolar disorder: data from STEP-BD.

Lauren B Marangell, Ellen B Dennehy, Sachiko Miyahara et al. Journal of affective disorders. 2009 Apr;114(1-3):58-67.

DOI 10.1016/j.jad.2008.07.006 | PMID 18708263

P04 Proposed multidimensional structure of mania: beyond the euphoric-dysphoric dichotomy.

H S Akiskal, J M Azorin, E G Hantouche. Journal of affective disorders. 2003 Jan;73(1-2):7-18.

DOI 10.1016/s0165-0327(02)00318-x | PMID 12507733

P05 Inhibition/activation in bipolar disorder: validation of the Multidimensional Assessment of Thymic States scale (MAThyS).

Chantal Henry, Amandine Luquiens, Christophe Lançon et al. BMC psychiatry. 2013 Mar 13;13:79.

DOI 10.1186/1471-244X-13-79 | PMID 23510483

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 2

P06 Re-evaluating the prevalence of and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders.

H S Akiskal, M L Bourgeois, J Angst et al. Journal of affective disorders. 2000 Sep;59 Suppl 1:S5-S30.

DOI 10.1016/s0165-0327(00)00203-2 | PMID 11121824

P07 Bipolar spectrum: a review of the concept and a vision for the future.

S Nassir Ghaemi. Psychiatry investigation. 2013 Sep;10(3):218-24.

DOI 10.4306/pi.2013.10.3.218 | PMID 24302943

P08 A new bipolar spectrum concept: a brief review.

Jules Angst, Alex Gamma. Bipolar disorders. 2002;4 Suppl 1:11-4.

DOI 10.1034/j.1399-5618.4.s1.1.x | PMID 12479669

P09 Mixed depressive states: nosologic and therapeutic issues.

Athanasios Koukopoulos, Matthew J Albert, Gabriele Sani et al. International review of psychiatry (Abingdon, England). 2005 Feb;17(1):21-37.

DOI 10.1080/09540260500064744 | PMID 16194768

P10 Depressive mixed states: A reappraisal of Koukopoulos' criteria.

Gianni L Faedda, Ciro Marangoni, Daniela Reginaldi. Journal of affective disorders. 2015 May 01;176:18-23.

DOI 10.1016/j.jad.2015.01.053 | PMID 25687279

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 3

P11 Rapid cycling bipolar disorder--diagnostic concepts.

Michael Bauer, Serge Beaulieu, David L Dunner et al. Bipolar disorders. 2008 Feb;10(1 Pt 2):153-62.

DOI 10.1111/j.1399-5618.2007.00560.x | PMID 18199234

P12 The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder.

Lewis L Judd, Hagop S Akiskal, Pamela J Schettler et al. Archives of general psychiatry. 2002 Jun;59(6):530-7.

DOI 10.1001/archpsyc.59.6.530 | PMID 12044195

P13 A prospective investigation of the natural history of the long-term weekly symptomatic status of bipolar II disorder.

Lewis L Judd, Hagop S Akiskal, Pamela J Schettler et al. Archives of general psychiatry. 2003 Mar;60(3):261-9.

DOI 10.1001/archpsyc.60.3.261 | PMID 12622659

P14 Subthreshold hypomanic symptoms in progression from unipolar major depression to bipolar disorder.

Jess G Fiedorowicz, Jean Endicott, Andrew C Leon et al. The American journal of psychiatry. 2011 Jan;168(1):40-8.

DOI 10.1176/appi.ajp.2010.10030328 | PMID 21078709

P15 The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017), Part 3: The Clinical Guidelines.

Konstantinos N Fountoulakis, Heinz Grunze, Eduard Vieta et al. The international journal of neuropsychopharmacology. 2017 Feb 01;20(2):180-195.

DOI 10.1093/ijnp/pyw109 | PMID 27941079

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.

Bibliografía verificada · 4

P16 Rapid cycling in bipolar disorder: a systematic review.

André F Carvalho, Dimos Dimellis, Xenia Gonda et al. The Journal of clinical psychiatry. 2014 Jun;75(6):e578-86.

DOI 10.4088/JCP.13r08905 | PMID 25004199

P17 An organization- and category-level comparison of diagnostic requirements for mental disorders in ICD-11 and DSM-5.

Michael B First, Wolfgang Gaebel, Mario Maj et al. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2021 Feb;20(1):34-51.

DOI 10.1002/wps.20825 | PMID 33432742

P18 Diagnostic conversion from depression to bipolar disorders: results of a long-term prospective study of hospital admissions.

Jules Angst, Robert Sellaro, Hans H Stassen et al. Journal of affective disorders. 2005 Feb;84(2-3):149-57.

DOI 10.1016/S0165-0327(03)00195-2 | PMID 15708412

Verificación en PubMed, 28-10-2026. P11 examina DSM-IV; P15 son guías de 2017. No se presentan como novedades terapéuticas de 2026. Cada entrada enlaza a PubMed.